

2026년 제8차 중증(암)질환심의위원회 사전 검토 보고

Leadership Brief | 2026.09.29 암질심 D-1 보완 점검

항목	내용
보고일	2026년 9월 29일(화) — 회의 D-1
회의	2026년 제8차 중증(암)질환심의위원회
회의 예정일	2026년 9월 30일(수)
보고 대상	보험약가 / Market Access Leadership
보고 목적	D-1 공개 신호를 반영한 예상 안건, 급여기준 확인 포인트, MSD read-through 정리

1. Executive Snapshot

한 줄 결론: 공식 사전 안건은 공개되지 않았으며, 현재 공개 신호 기준으로는 샘블릭스(애시미닙) 1차 만성골수성백혈병 치료 확대가 최우선 확인 후보다. 임델트라와 키트루다 재도전은 환자 접근성·임상 데이터 신호는 있으나, 공식 재신청·보완자료 또는 구체적인 회의 직전 확인이 부족해 확정 후보가 아닌 Watch로 유지한다.

핵심 메시지	Leadership Implication
샘블릭스는 복수 전문매체에서 9월 30일 회의 상정 예정 신호가 확인됨	상정 여부와 함께 1차 치료 대상군, 치료 전환 조건, 장기 투여 재정관리 문구를 우선 확인
임델트라는 6차·7차 연속 미상정 이후에도 public-pressure만으로는 상정 확률을 높일 수 없음	회사의 재신청·보완자료와 회의 직전 구체 차수 신호가 확인되기 전까지 보수적 Watch 유지
직전 7차는 동일 약제도 병용요법별로 급여기준 설정과 미설정일 갈림	약물 단위가 아니라 적응증·병용요법·치료라인 단위로 D+1 결과를 판독

2. 직전 차수 결과 — 이번 회의의 기준선

제7차 중증(암)질환심의위원회 (2026-08-19)

약제/요법	영역	공식 결과	이번 회의 연결 해석
브렌랩주 + 보르테조미드·덱사메타손	재발·불응성 다발골수종	급여기준 설정	동일 약제라도 병용 파트너별 기준을 분리해 확인해야 함
브렌랩주 + 포말리도마이드·덱사메타손	재발·불응성 다발골수종	급여기준 미설정	임상·재정 근거의 regimen-level 문턱이 결과를 좌우
보라니고정	IDH1/2 변이 2등급 교종	급여기준 설정	바이오마커·수술 후 대상군·연령 조건이 기준문구의 핵심
브루킨사캡슐	치료 경험이 있는 CLL/SLL	급여기준 설정	혈액암 표적치료제의 대상군 제한과 기존 치료 이력 확인 필요
도세탁셀+트라스투주맵	HER2 양성 침샘도관암	급여기준 미설정	희귀 암종 병용요법은 근거·대상군 정의가 핵심 제약

7차 결과는 약제명 = 결과로 단순화할 수 없음을 보여준다. 8차에서도 상정 여부뿐 아니라 적응증, 병용 파트너, 치료라인, 바이오마커 조건을 분리해 읽어야 한다.

3. 제8차 암질심 예상 안건 — Leadership Watchlist

HIRA는 사전 안건을 공식 공개하지 않는다. 아래는 9월 29일 현재 공개된 일정·전문매체 신호·직전 결과를 종합한 관찰 우선순위이며, 실제 상정과 결과는 HIRA 공식 발표로 확정한다.

우선순위	약제/요법	회사	영역	현재 판단	Leadership 관찰 포인트
High	셈블릭스 (애시미닙)	한국노바티스	CML 1차 치료 확대	복수 전문매체에서 9/30 상정 예정 신호	ASC4FIRST 근거의 1차 대상군, 기존 치료와의 전환 조건, 장기 투여 관리 확인
Medium	임델트라 (탈라타맵)	암젠코리아	소세포폐암 2차 이상	반복 미상정 이력. public-pressure 신호만으로는 확정 불가	재신청·보완자료 제출, OS 성숙도, GIFT·급여기준 연계 여부 확인
Medium	키트루다 (팜브롤리주맵) 재도전	한국MSD	적응증 확대 가능성	새 임상 데이터 관련 보도 신호는 있으나 적응증·공식 회의 신호 미확정	대상 환자군, biomarker, 기존 급여범위와의 경계, 재정관리 조건 확인
Watch	퍼제타주 (퍼투주맵) 확대	한국로슈	HER2 양성 유방암 보조요법	6차 재논의 후 보완자료·재상정 여부 미확인	재논의가 실제 안건으로 연결되는지와 수술 전·후 범위 분리 확인
Watch	티루캅정 (카피바설팅)	한국아스트라 제네카	HR+/HER2- 유방암	과거 미설정 이후 재신청 신호 미확인	보완자료가 미설정 사유를 직접 해소했는지, 바이오마커·병용 조건 확인
Open	기존 급여약제 기준 확대·정비	복수 회사	병용·급여기준 확대	사전 공개가 제한되어 개별 후보 특정 불가	신규 품목 외 기존 확대와 regimen 단위 안건을 결과표에서 전수 확인

후보별 핵심 해석

셈블릭스: 이번 회차에서 가장 구체적인 공개 신호가 있는 후보다. 상정될 경우 단순한 약제 추가보다 1차 치료에서의 환자 선별, 기존 표준요법 대비 전환 시점, 장기 투여에 따른 재정영향 관리가 결과의 핵심이다.

임델트라: 환자 접근성·미충족 수요는 분명하지만, 이전 차수에서 사회적 압박만으로 상정되지 않았다. D-1에도 회사의 공식 재신청·보완자료 또는 미설정 사유를 직접 해소하는 근거가 확인되지 않으면 Watch 수준을 유지하는 것이 안전하다.

키트루다: MSD 직접 자산 후보로서 상정 여부보다 적응증 단위 판독이 중요하다. 실제 안건이면 biomarker, line of therapy, 기존 급여범위와의 경계 및 병용요법의 재정관리 방식을 D+1에서 우선 확인한다.

4. MSD 관점의 주요 영향

영역	관찰 내용	MSD 대응 관점
직접 안건	키트루다 재도전은 공개 신호만으로 확정할 수 없음	상정 확인 전까지 적응증별 근거·대상군·재정영향 자료의 즉시 검토 상태 유지
면역항암 병용	7차에서 regimen별 급여기준이 분리됨	동일 약물의 다른 병용·치료라인을 한 결과로 묶지 않고 별도 access scenario로 관리
경쟁 약제	셈블릭스 1차 확대가 실제 상정되면 혈액암 영역의 근거·전환 조건 논의가 구체화될 수 있음	심의 문구에서 대상군 제한, 전환 기준, 장기 투여 관리의 구조를 추출해 타 영역 read-through 검토
정책·재정	신규 품목보다 기존 급여기준 확대·정비 안건이 함께 등장할 수 있음	약제 단위보다 적응증·라인·병용조합별 BIA와 급여범위 경계를 준비

5. 결과 발표 후 확인해야 할 사항

확인 항목	왜 중요한가
셈블릭스의 실제 상정 및 1차 CML 결과	가장 구체적인 D-1 후보 신호의 적중 여부와 1차 확대 기준선 확인
키트루다의 상정 여부·적응증·biomarker	MSD 직접 영향과 기존 급여범위의 경계를 확정
임델트라·키트루다의 상정 여부 및 OS·보완자료 반영	public-pressure와 실제 안전화의 관계를 재평가
병용요법별 급여기준 문구	동일 약제의 regimen별 결과 분리 여부와 후속 접근성 판단에 필요
급여기준 설정·미설정·재논의의 공식 표현	결과를 약물 단위로 오독하지 않고 환자군·라인별로 연결하기 위해 필요
9월 30일 결과표의 비공개 후보 전수 확인	사전 신호가 없는 기존 급여기준 확대·회귀 암종 안전 누락 방지

6. Source & Caveat

- 건강보험심사평가원 공식 보도자료와 세부 급여기준이 상정 여부·심의 결과의 최종 권위다.
- HIRA는 사전 안전을 공개하지 않으므로 본 문서의 후보는 공개 일정·전문매체 신호·직전 공식 결과를 바탕으로 한 사전 관찰 목록이다.
- 셈블릭스의 회의 직전 상정 신호는 전문매체 보조 근거이며, HIRA 공식 안전 또는 결과를 대체하지 않는다.
- 임델트라·키트루다·퍼제타·티루캡은 적응증과 회의별 공식 확인이 없으면 확정 후보로 해석하지 않는다.
- 최종 상정·급여기준 설정 여부는 2026년 9월 30일 이후 HIRA 공식 결과 공개 시 D+1 리뷰에서 확정한다.

본 보고서는 리더십 의사결정을 위한 독립 사전 검토 자료이며, 공개되지 않은 HIRA 내부 안전이나 회사의 비공개 협상 정보를 주장하지 않는다.